

Nomor : PR.01.08/A/5636/2025
Lampiran : satu berkas
Hal : Rincian Kegiatan Bersumber DBH CHT untuk
Program Pembinaan Lingkungan Sosial,
Bidang Kesehatan

30 November 2025

Yth.

1. Gubernur

2. Bupati/Walikota

Penerima DBH CHT di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Prinsip penggunaan DBH CHT di bidang kesehatan adalah untuk mendanai program sebagaimana tertuang dalam PMK 72/2024 Pasal 2 ayat (1) huruf c, yaitu pembinaan lingkungan sosial.
2. Penggunaan DBH CHT untuk bidang kesehatan dianggarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa DBH CHT.
3. Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesehatan meliputi kegiatan:
 - a. pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya:
 - 1) penurunan angka prevalensi merokok meliputi:
 - a) kampanye, sosialisasi, dan edukasi bahaya merokok;
 - b) penerapan kawasan tanpa rokok;
 - c) upaya berhenti merokok;
 - d) survei konsumsi produk tembakau; dan/atau
 - e) pengendalian iklan, promosi dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.
 - 2) percepatan penurunan angka prevalensi stunting;
 - 3) peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah 5 (lima) tahun;
 - 5) penanggulangan dan penanganan penyakit paru, saluran pernapasan, dan kanker akibat merokok; dan/atau
 - 6) pencegahan dan penanggulangan infeksi dan resistensi antimikroba;
 - b. penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan;

- c. penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada fasilitas kesehatan;
 - d. pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - e. pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan; dan/atau
 - f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran kader.
4. Terlampir kami sampaikan Rincian Kegiatan yang dapat dibiayai dengan DBH CHT untuk dapat dipedomani.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
3. Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit
4. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan
5. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
6. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

Lampiran

Nomor : PR.01.08/A/5636/2025

Tanggal : 30 November 2025

RINCIAN KEGIATAN
BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT)
UNTUK PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL
BIDANG KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah kebijakan pembangunan kesehatan dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan yaitu dengan rumusan: “Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”. Strategi yang dikembangkan untuk mencapai arah kebijakan tersebut, yaitu:

1. Transformasi pelayanan kesehatan primer menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang lebih berkualitas.
2. Transformasi pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka penyediaan layanan rujukan yang lebih berkualitas.
3. Transformasi menuju ke sistem ketahanan kesehatan yang tangguh.
4. Transformasi pembiayaan kesehatan dilakukan untuk menuju pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan ketersediaan, kecukupan, keberlanjutan, keadilan serta efektivitas dan efisiensi pada penyelenggaraan pembiayaan.
5. Transformasi SDM kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang kompeten, merata serta berkeadilan.
6. Transformasi teknologi kesehatan menuju pada digitalisasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas pada sektor kesehatan.

7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang kesehatan.

Berbagai potensi dan tantangan mempengaruhi arah dan strategi pembangunan kesehatan di Indonesia, salah satunya yakni potensi dan tantangan kontraksi ekonomi berakibat pada kontraksi anggaran kesehatan. Kontraksi ekonomi memberi tekanan besar pada ruang fiskal bagi belanja kesehatan. Krisis multi-dimensi yang disertai meningkatnya kebutuhan kesehatan yang sangat tidak menentu, memperburuk sistem kesehatan Indonesia yang selama beberapa dekade terkendala rendahnya pengeluaran kesehatan, bahkan termasuk yang terendah dari negara-negara sedang berkembang berpenghasilan menengah-bawah. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan mengantisipasi dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan sebagai penanggulangan pandemi, yang salah satunya adalah refokusing dan realokasi anggaran.

Potensi dan tantangan penganggaran pembangunan kesehatan antisipasinya diberi ruang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, berupa implementasi hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD

meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar Daerah, pengelolaan TKD akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah. Selain itu, pengalokasian DBH akan memperhitungkan kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

DBH merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

Penggunaan DBH CHT diatur pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau, salah satunya untuk membiayai program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesehatan. DBH CHT Bidang Kesehatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan lebih difokuskan pada kegiatan promotif, preventif, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan sumberdaya manusia kesehatan di fasilitas kesehatan untuk mendukung pencapaian program prioritas transformasi kesehatan.

B. Kebijakan Umum

1. DBH CHT untuk mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan sumberdaya manusia kesehatan di fasilitas kesehatan untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional, transformasi kesehatan dan prioritas daerah.
2. Manajemen pelaksanaan program kegiatan yang didanai DBH CHT Bidang Kesehatan meliputi: 1) Perencanaan dan Penganggaran, 2) Pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan dan 3) Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi berpedoman pada ketentuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

3. Dalam pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai sumber DBH CHT untuk menghindari terjadinya duplikasi dengan sumber pembiayaan APBN, APBD maupun pembiayaan lainnya.
4. Jenis belanja kegiatan dan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai sumber DBH CHT menjadi tanggung jawab muntlak Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang di danai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Rincian Kegiatan Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Untuk Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan lebih difokuskan pada kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, berikutnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan sumberdaya manusia kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas transformasi kesehatan.

D. Tujuan

Tujuan dari Rincian Kegiatan Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Untuk Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Memberikan acuan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan sumberdaya manusia kesehatan, melalui penerimaan DBH CHT Bidang Kesehatan, sehingga tepat guna, tepat sasaran dan memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya pemecahan permasalahan kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. Meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan lebih difokuskan pada kegiatan promotif, preventif, rehabilitatif, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan sumberdaya manusia kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas transformasi kesehatan.
- c. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang didanai DBH CHT Bidang Kesehatan oleh pemerintah daerah.

E. Sasaran

Sasaran program kegiatan bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan meliputi:

1. Dinas Kesehatan provinsi;
2. Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
3. Fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota meliputi ; Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Laboratorium kesehatan Masyarakat, Instalasi Gudang Farmasi, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (UPKD/K) dan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
4. Sasaran program kegiatan.

F. Pengertian

Dalam Rincian Kegiatan Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Untuk Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan ini yang dimaksud:

1. Menteri Kesehatan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi provinsi atau bupati bagi kabupaten atau wali kota bagi kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
9. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
11. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Rokok elektronik merupakan hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
13. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam

melakukan Upaya Kesehatan.

14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
16. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
18. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.
19. Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
20. Bahan Medis Habis Pakai selanjutnya disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
21. Sarana adalah bangunan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan dan digunakan untuk penyelenggaraan atau penunjang pelayanan.
22. Prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu Sarana

dapat berfungsi.

23. Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang selanjutnya disingkat ASPAK adalah suatu aplikasi berbasis web yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
24. Sistem Informasi Kesehatan adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai tahapan pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Kesehatan serta mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan Kesehatan.
25. Data Kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan Kesehatan
26. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
27. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
28. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
29. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
30. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
31. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan

sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.

32. Kader Posyandu Bidang Kesehatan selanjutnya disebut Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.
33. Kader Unit Pelayanan Kesehatan Desa/ Kelurahan selanjutnya disebut Kader UPKD/K adalah anggota masyarakat yang memiliki pengalaman sebagai kader posyandu atau memiliki Pendidikan tenaga kesehatan untuk membantu kepala desa/lurah dalam pemberdayaan Masyarakat di UPKD/K, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Tingkat desa/ kelurahan bersama tenaga kesehatan UPKD/K.
34. Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan adalah Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan merupakan jaringan atau jejaring Puskesmas yang menyelenggarakan tata kelola Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tata kelola Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

II. TATA CARA PELAKSANAAN RINCIAN KEGIATAN BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT) UNTUK PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN

A. Pelayanan Kesehatan Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif Dengan Prioritas Mendukung Upaya:

1. Penurunan Angka Prevalensi Merokok meliputi:

a. Kampanye, Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Merokok Bagi Kesehatan.

Kampanye, sosialisasi, dan edukasi mengenai bahaya merokok bagi kesehatan merupakan upaya strategis yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok. Kegiatan ini meliputi penyebaran informasi yang komprehensif mengenai dampak negatif merokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektronik, seperti penyakit kardiovaskular, kanker, dan gangguan pernapasan, bahaya perokok pasif serta dampak terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, program ini juga berfokus pada skrining perilaku merokok dan penyediaan edukasi

terkait manfaat berhenti merokok, serta dukungan bagi para perokok aktif yang ingin berhenti merokok. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi perokok pemula, perokok aktif serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat di masyarakat.

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Kampanye, Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Merokok bagi kesehatan dalam bentuk:

- 1) Pembuatan iklan layanan masyarakat (ILM);
- 2) Pelaksanaan kampanye kreatif kesehatan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan kampanye dan edukasi yang terintegrasi yang bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- 4) Pelibatan teman sebaya, OSIS, karang taruna dan organisasi pemuda lainnya;
- 5) Penyuluhan bahaya produk tembakau, berupa kegiatan *workshop* di lingkungan satuan pendidikan dan di masyarakat umum;
- 6) Pelaksanaan kegiatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) setiap bulan Mei.
- 7) Penyelenggaraan Gerakan janji hidup sehat.

Pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Kampanye, Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Merokok Bagi Kesehatan tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tujuan Umum
 - a) Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang dampak buruk konsumsi produk tembakau dan rokok.
 - b) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan perilaku hidup sehat untuk mencegah penyakit tidak menular untuk tidak merokok
- 2) Tujuan Khusus
 - a) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak buruk konsumsi produk tembakau dan rokok.
 - b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan peningkatan gaya hidup sehat masyarakat.
 - c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait agar berperan aktif pada upaya edukasi untuk hidup sehat tanpa rokok.
 - d) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk konsumsi produk tembakau dan rokok

bagi kesehatan untuk mendukung penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan

- e) Meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya perilaku pencegahan penyakit menular tidak merokok melalui komitmen dan kolaborasi mitra potensial terkait dalam rangka penyelenggaraan Janji Hidup Sehat

3) Sasaran

- a) Masyarakat
- b) Anak usia sekolah dan remaja

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c) Puskesmas

5) Keluaran

- a) Jumlah frekwensi kegiatan pelaksanaan Pembuatan iklan layanan masyarakat (ILM)
- b) Jumlah frekwensi kegiatan Pelaksanaan kampanye kreatif kesehatan masyarakat
- c) Jumlah frekwensi kegiatan Pelaksanaan kampanye dan edukasi yang terintegrasi yang bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat
- d) Jumlah frekwensi kegiatan pelaksanaan Pelibatan teman sebaya, OSIS, karang taruna dan organisasi pemuda lainnya.
- e) Jumlah frekwensi kegiatan pelaksanaan Penyuluhan bahaya produk tembakau, berupa kegiatan workshop di lingkungan satuan pendidikan dan di masyarakat umum
- f) Jumlah frekwensi kegiatan Pelaksanaan kegiatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) setiap bulan Mei
- g) Jumlah frekwensi kegiatan Pelaksanaan kegiatan Gerakan Janji Hidup Sehat.

b. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 443 menyatakan bahwa Pemerintah daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan peraturan daerah. Tujuannya adalah untuk

melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan khususnya anak-remaja, wanita hamil dari paparan asap rokok orang lain.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dan wajib diterapkan di 7 (Tujuh) tatanan yang meliputi tempat belajar mengajar, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat bermain anak, tempat kerja, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat umum lainnya yang ditetapkan. Untuk optimalitas penerapan KTR, diperlukan pengawasan dan penegakan kepatuhan implementasi oleh satuan tugas yang dibentuk.

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR):

- 1) Sosialisasi Perda KTR;
- 2) Pengawasan implementasi KTR di 7 (Tujuh) tatanan;
- 3) Penegakan kepatuhan atas pelanggaran KTR;
- 4) Penilaian dan pemberian penghargaan bagi Tatanan yang menerapkan KTR tingkat Kabupaten/Kota;
- 5) Monitoring dan evaluasi KTR dengan sistem informasi digital;
- 6) Penyelenggaraan Janji Hidup Sehat

Pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tujuan Umum
 - a) Menyebarluaskan informasi pentingnya kawasan tanpa rokok dalam rangka melindungi generasi muda, wanita hamil dari dampak buruk merokok dan paparan asap rokok orang lain.
 - b) Pengawasan dalam rangka penerapan Peraturan Daerah tentang KTR di 7 (tujuh) tatanan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan.
 - c) Penegakan kepatuhan penerapan KTR kepada pimpinan/ penanggung jawab KTR dan masyarakat.
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi penegakan kepatuhan KTR di lapangan dengan pemanfaatan aplikasi monev e-KTR berbasis android.
- 2) Tujuan Khusus

- a) Mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan untuk dapat diimplementasikan oleh pimpinan/penanggungjawab/ pengelola KTR dan masyarakat.
 - b) Mensosialisasikan kawasan/tatanan yang ditetapkan sebagai KTR kepada pimpinan/ penanggung/ pengelola jawab KTR dan masyarakat.
 - c) Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum implementasi kawasan tanpa rokok di 7 (Tujuh) tatanan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan.
- 3) Sasaran
- a) Pimpinan/penanggung jawab/pengelola KTR serta masyarakat.
 - b) 7 (Tujuh) tatanan yang telah ditetapkan sebagai KTR.
 - c) Kepala Daerah Bupati/Walikota
- 4) Pelaksana Kegiatan
- a) Dinas Kesehatan Provinsi
 - b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- 5) Keluaran
- a) Jumlah frekwensi kegiatan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah KTR
 - b) Jumlah frekwensi kegiatan pelaksanaan Pengawasan implementasi KTR di 7 (Tujuh) tatanan
 - c) Jumlah paket kegiatan pelaksanaan Penegakan kepatuhan atas pelanggaran KTR
 - d) Jumlah frekwensi kegiatan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan bagi Tatanan yang menerapkan KTR tingkat Kabupaten/Kota
 - e) Jumlah frekwensi kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KTR KTR dengan sistem informasi digital
- c. Upaya Berhenti Merokok (UBM).

Layanan Konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) merupakan salah satu upaya dalam membantu masyarakat untuk berhenti merokok dan mengatasi gejala putus nikotin. Gejala putus nikotin (*withdrawal effect*) dapat berupa perubahan emosi dan perilaku. Sebagian perokok dapat berhenti tanpa mengalami gejala putus nikotin, namun sebagian

lagi masih mengalami kecanduan kembali merokok. Sehingga diperlukan bantuan tenaga kesehatan melalui Layanan UBM agar dapat membantu mereka yang kesulitan untuk berhenti merokok.

Kegiatan konseling berhenti merokok dapat dilakukan terintegrasi dengan program lain seperti program *Practical Approach to Lung Health (PAL)*, kegiatan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM, deteksi dini program kesehatan jiwa yang menggunakan instrumen *Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST)*, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui penjangkaran awal dan skrining berhenti merokok berkala di sekolah, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

Layanan konseling UBM adalah suatu layanan konseling kepada seseorang yang ingin berhenti merokok yang diberikan oleh seorang tenaga terlatih. Layanan konseling UBM di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dilaksanakan 2 minggu sekali selama 3 bulan pertama dengan durasi waktu 30 hingga 60 menit, atau dilakukan minimal 6 kali pertemuan untuk setiap klien.

Adanya layanan konseling UBM diharapkan agar para perokok dengan kesadarannya sendiri atau adanya dukungan dari orang-orang disekitar dapat berhenti merokok sehingga jumlah perokok semakin berkurang dan mengurangi risiko dari dampak rokok bagi kesehatan.

Sejak tahun 2016 Kementerian Kesehatan telah memiliki Layanan konseling berhenti merokok Quitline.Ina berbasis telepon tidak berbayar pada nomor 0800-177-6565, yang dapat diakses pada hari senin-sabtu pada jam kerja.

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Berhenti Merokok (UBM):

- 1) Penyediaan Layanan Konseling Berhenti Merokok Dengan Telepon Tidak Berbayar Ditingkat Daerah
 - a) Tujuan Umum

Melakukan integrasi layanan berhenti merokok Quitline.Ina dengan Upaya Berhenti Merokok di Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas.
 - b) Tujuan Khusus
 - (1) Mengintegrasikan layanan Quitline.Ina berbasis telepon tidak berbayar dengan layanan UBM puskesmas.

- (2) Pelaksanaan konseling UBM berbasis telepon yang mendekatkan kepada klien.
 - (3) Tersedia/ada layanan konseling UBM terintegrasi Quitline.Ina dengan Layanan UBM di Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas.
 - c) Sasaran
Masyarakat
 - d) Pelaksana Kegiatan
 - (1) Dinas Kesehatan Provinsi
 - (2) Dinas Kesehatan Kab/Kota.
 - (3) Puskesmas.
 - e) Keluaran
 - (1) Jumlah frekwensi kegiatan pelaksanaan pengadaan sarana, prasarana dan media layanan konseling UBM terintegrasi Quitline.Ina
 - (2) Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan Konseling Berhenti Merokok
- 2) Penyediaan Layanan Berhenti Merokok Di Tatanan Kawasan Tanpa Rokok
- a) Tujuan Umum
Terselenggaranya layanan berhenti merokok di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
 - b) Tujuan Khusus
Menjaring lebih banyak perokok yang berkeinginan berhenti merokok tetapi mengalami kesulitan.
 - c) Sasaran
Masyarakat
 - d) Pelaksana Kegiatan
 - (1) Dinas Kesehatan Provinsi
 - (2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - (3) Puskesmas
 - e) Keluaran
 - (1) Jumlah frekwensi kegiatan pelaksanaan penyediaan unit sarana layanan berhenti merokok di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR

- (2) Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan berhenti merokok di kawasan yang ditetapkan KTR
- 3) Sosialisasi Layanan Upaya berhenti merokok.
 - a) Tujuan Umum
Menyebarkan informasi tentang layanan berhenti merokok kepada masyarakat
 - b) Tujuan Khusus
 - (1) Mendekatkan layanan layanan berhenti merokok kepada masyarakat.
 - (2) Memberikan kesempatan kepada klien yang kesulitan berhenti merokok untuk dapat berhenti merokok.
 - c) Sasaran
Masyarakat
 - d) Pelaksana Kegiatan
 - (1) Dinas Kesehatan Provinsi
 - (2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - (3) Puskesmas
 - e) Keluaran
Jumlah frekwensi kegiatan pelaksanaan sosialisasi layanan berhenti merokok
- d. Survei Konsumsi Produk Tembakau.

Untuk dapat mengetahui perkembangan penggunaan produk tembakau maupun rokok elektronik sangat diperlukan survei secara berkelanjutan setiap tahun. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat melakukan survei sebagaimana dimaksud dalam rangka pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan dalam menurunkan prevalensi perokok pemula usia 10 - 21 tahun.

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Survei konsumsi produk tembakau:

- 1) Pelaksanaan Survey/Pemantauan Konsumsi Produk Tembakau.
 - a) Tujuan Umum
Mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang penggunaan produk tembakau dan rokok elektronik dalam rangka menurunkan prevalensi perokok pemula usia 10 - 21 tahun.
 - b) Tujuan Khusus

Melakukan survei penggunaan produk tembakau dan rokok elektronik bekerja sama dengan Universitas/Perguruan Tinggi setempat, LSM Pengendalian Tembakau setiap tahun.

c) Sasaran

Masyarakat

d) Pelaksana Kegiatan

(1) Dinas Kesehatan Provinsi

(2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan berkolaborasi dengan Universitas/Perguruan Tinggi, LSM pengendalian tembakau.

e) Keluaran

Jumlah dokumen hasil survei kesehatan dalam pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik.

2) Pelaksanaan Diseminasi Hasil Survey

a) Tujuan Umum

Menyebarkan informasi hasil survei yang telah dilakukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, dan masyarakat.

b) Tujuan Khusus

(1) Pimpinan daerah dan OPD mendapatkan gambaran hasil survei untuk ditindak lanjut dengan kebijakan program.

(2) Masyarakat mendapatkan gambaran untuk perubahan perilaku hidup sehat.

c) Sasaran

Pimpinan daerah, OPD, LSM, Media dan Masyarakat.

d) Pelaksana Kegiatan

(1) Dinas Kesehatan Provinsi

(2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan berkolaborasi dengan Universitas/Perguruan Tinggi, LSM pengendalian tembakau.

e) Keluaran

Jumlah frekwensi kegiatan pelaksanaan Diseminasi data hasil survei

e. Pengendalian Iklan, Promosi dan Sponsor Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Media sosial dan penyiaran memperkuat normalisasi perilaku merokok, sedangkan penelitian menyebutkan bahwa remaja yang

terpapar iklan rokok lebih mungkin untuk mencoba merokok. Akibatnya, Indonesia menghadapi beban kesehatan yang besar, termasuk meningkatnya kasus penyakit paru dan jantung terkait merokok. Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Iklan rokok di Indonesia sering menyasar remaja melalui berbagai saluran, termasuk media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta iklan TV yang menampilkan gaya hidup glamor. Banyak kampanye juga menggunakan influencer untuk menjangkau audiens muda. Remaja terpapar iklan rokok meningkatkan ketertarikan mereka untuk merokok. Sebaran Iklan rokok ini memperkuat citra positif terhadap merokok, yang berpotensi memperburuk masalah kesehatan masyarakat.

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pengendalian Iklan, Promosi dan Sponsor Produk Tembakau dan Rokok Elektronik:

- 1) Pengendalian Iklan Produk Tembakau di Media Luar Ruang,
 - a) Tujuan Umum
 - (1) Menyebarluaskan informasi melalui sosialisasi pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik dalam rangka perlindungan kepada anak-remaja.
 - (2) Pengendalian Promosi dan sponsorship produk tembakau yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengamanan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, Larangan penjualan rokok secara batangan, Larangan penjualan rokok pada usia dibawah 21 tahun dan wanita hamil, Pemantauan *display* penjualan rokok konvensional dan rokok elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan.
 - b) Tujuan Khusus
 - (1) Masyarakat berperan aktif melaporkan bila ada iklan produk tembakau dan rokok elektronik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Masyarakat berperan aktif melaporkan bila masih ada penjualan rokok secara eceran per batang.
 - (3) Masyarakat berperan aktif melaporkan bila ada penjualan rokok kepada anak usia <21 tahun.

- (4) Tidak ada lagi iklan, promosi dan sponsorship produk tembakau dan rokok elektronik yang dipasang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tidak ada lagi masyarakat yang menjual rokok dengan cara memajang rokok tetapi dengan cara ditutup, hanya perlu ditulis “disini jual rokok”
 - c) Sasaran
Pimpinan daerah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat
 - d) Pelaksana Kegiatan
 - (1) Dinas Kesehatan Provinsi
 - (2) Dinas Kesehatan Kabupaten/KotaPelaksanaan kegiatan berkolaborasi dengan Tim Satgas Penegak KTR
 - e) Keluaran
Jumlah orang, masyarakat sebagai pedagang/penjual rokok diadvokasi patuh terhadap aturan
- 2) Pelaksanaan Pertemuan Evaluasi Kegiatan Pengawasan Iklan Promosi Sponsor.
- a) Tujuan Umum
Melaksanakan evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan pengendalian iklan setiap 6 bulan sekali.
 - b) Tujuan Khusus
 - (1) Evaluasi terhadap penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok
 - (2) Evaluasi kepatuhan masyarakat
 - (3) Evaluasi terkait kendala yang dihadapi dan penyelesaian masalah terkait iklan produk tembakau maupun rokok elektronik
 - (4) Evaluasi terhadap pembiayaan kegiatan
 - c) Sasaran
Pimpinan daerah, seluruh OPD dan masyarakat
 - d) Pelaksana Kegiatan
 - (1) Dinas Kesehatan Provinsi
 - (2) Dinas Kesehatan Kabupaten/KotaPelaksanaan kegiatan berkolaborasi dengan Tim Satgas Penegak KTR

- e) Keluaran
Jumlah frekwensi kegiatan pelaksanaan pertemuan evaluasi kegiatan pengawasan Iklan Promosi Sponsor
- 3) Pelaksanaan Pembinaan Teknis Pengendalian Iklan Promosi Sponsor
 - a) Tujuan Umum
Penyegaran, peningkatan kemampuan bagi tim satuan tugas penegak KTR dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan terkait pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik
 - b) Tujuan Khusus
 - (1) Penyampaian informasi terkini dalam pengendalian iklan promosi dan sponsor rokok.
 - (2) Penyelesaian masalah / aduan masyarakat terkait iklan promosi dan sponsor rokok
 - c) Sasaran
Tim satuan tugas penegak KTR dan OPD terkait
 - d) Pelaksana Kegiatan
 - (1) Dinas Kesehatan Provinsi
 - (2) Dinas Kesehatan Kabupaten/KotaPelaksanaan kegiatan berkolaborasi jaringan pengendalian tembakau
 - e) Keluaran
Jumlah frekwensi kegiatan pelaksanaan pembinaan teknis pengendalian Iklan Promosi Sponsor

2. Percepatan Penurunan Angka Prevalensi *Stunting*

Penyebab stunting adalah multifaktorial dan berkaitan dengan asupan gizi yang kurang atau kebutuhan gizi yang meningkat. Permasalahan stunting di Indonesia memberikan risiko dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Tingginya permasalahan stunting perlu ditanggulangi dengan upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting, khususnya bidang kesehatan. Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting antara lain berupa pemeriksaan ANC minimal 6 (enam) kali pada ibu hamil, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian makanan tambahan bagi balita bermasalah gizi dan sebagainya.

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting:

a. Edukasi dan Sosialisasi Remaja Putri, Ibu Hamil, Ibu/Pengasuh Balita dan Keluarga

1) Tujuan Umum

Meningkatkan pengetahuan masyarakat, remaja putri, ibu hamil, ibu/pengasuh balita dan keluarganya terkait intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting

2) Tujuan Khusus

- a) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
- b) Menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk ikut mengkampanyekan dan terlibat aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting.

3) Sasaran

Remaja putri, ibu hamil, ibu dan pengasuh balita, keluarga ibu hamil dan keluarga, ibu/pengasuh balita, warga sekolah, pengampu kebijakan tingkat desa dan kecamatan, tokoh masyarakat, adat dan agama, petugas puskesmas, dan kader posyandu

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kab/Kota
- c) Puskesmas

Pelaksanaan kegiatan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat pada semua tingkatan administrasi.

5) Keluaran

- a) Jumlah paket Media edukasi cetak (brosur, leaflet, infografis, poster), elektronik dan online tentang upaya penurunan stunting paket berlangganan pesan broadcast, pemeliharaan media online/media sosial dan lain lain.
- b) Jumlah frekwensi pelaksanaan kegiatan: Seminar, workshop, talkshow, lomba, pameran, atau kampanye tentang upaya penurunan stunting kelas ibu hamil dan ibu/pengasuh balita secara berkala, rembug stunting tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

- c) Jumlah remaja putri, ibu hamil, ibu pengasuh balita, keluarga ibu hamil dan keluarga ibu/pengasuh balita yang mendapatkan sosialisasi/edukasi.
- d) Jumlah orang anggota masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
- b. Advokasi dan Sosialisasi Terkait Intervensi Spesifik Untuk Percepatan Penurunan Stunting
 - 1) Tujuan Umum

Penguatan komitmen pemerintah di semua tingkatan administrasi dengan dukungan dari seluruh program dan sektor serta mitra dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting
 - 2) Tujuan Khusus
 - a) Penguatan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di provinsi kabupaten/ kota dan desa
 - b) Penguatan konvergensi di tingkat provinsi kabupaten/ kota dan desa
 - c) Penguatan implementasi intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting berbasis sasaran (sasaran sebelum lahir dan sesudah lahir)
 - d) Peningkatan kemampuan kolaborasi dalam memecahkan permasalahan terkait faktor penyebab terjadinya stunting
 - e) Mengembangkan inovasi yang dapat memberikan daya ungkit dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting
 - f) Terselenggaranya rembug stunting yang efektif dan efisien berdasarkan analisis situasi dalam membahas permasalahan serta upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di masing masing level administrasi
 - 3) Sasaran
 - a) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat provinsi kabupaten/ kota dan desa terutama di Provinsi Prioritas Stunting
 - b) Lintas Sektor Terkait
 - c) Perguruan Tinggi dan Poltekkes
 - d) Dunia Usaha
 - 4) Pelaksana Kegiatan
 - a) Dinas Kesehatan Provinsi

- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Pelaksana kegiatan berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Daerah
- 5) Keluaran
Jumlah frekwensi pelaksanaan kegiatan Advokasi dan Sosialisasi
Terkait Intervensi Spesifik Untuk Percepatan Penurunan Stunting
- c. Pemberian Makanan Tambahan

Pemberian makanan tambahan pangan lokal yang diberikan untuk memenuhi kesenjangan asupan gizi guna memperbaiki masalah dan meningkatkan status gizi pada sasaran. Melalui pemanfaatan pangan lokal tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan ketahanan pangan.

Kegiatan PMT berbahan pangan lokal tersebut perlu disertai dengan edukasi gizi dan kesehatan untuk perubahan perilaku misalnya dengan mendukung pemberian ASI, edukasi dan konseling pemberian makan, kebersihan serta sanitasi untuk keluarga.

PMT diberikan dengan mengutamakan penggunaan bahan pangan bersumber hewan dan memperhatikan ragam makanan serta kebiasaan lokal.

- 1) Tujuan Umum
Pembuatan, pemberian dan distribusi makanan tambahan (penyuluhan atau pemulihan) bagi ibu hamil, bayi dan balita sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan
- 2) Tujuan Khusus
 - a) Pembuatan dan pemberian makanan tambahan (penyuluhan atau pun pemulihan) berbahan dasar pangan lokal kepada kelompok sasaran (ibu hamil, bayi dan balita) berdasarkan status gizi (baik atau bermasalah gizi) sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
 - b) Pengiriman/distribusi makanan tambahan pemulihan bagi ibu hamil, bayi dan balita bermasalah gizi
- 3) Sasaran
 - a) Ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) Pra hamil atau pada Trimester 1 (< 12 minggu) kurang dari $18,5 \text{ kg/m}^2$
 - b) Ibu hamil kurang energi kronis (KEK) yang mempunyai ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari $23,5 \text{ cm}$
 - c) Balita berat badan tidak naik (1 T) dengan atau tanpa stunting

- d) Balita berat badan kurang, dengan atau tanpa stunting
- e) Balita gizi kurang, dengan atau tanpa stunting
- f) Ibu hamil dengan status gizi normal
- g) Bayi dan balita dengan status gizi normal
- 4) Pelaksana Kegiatan
 - a) Dinas Kesehatan Provinsi
 - b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - c) Puskesmas dan Kader Kesehatan
- 5) Keluaran
 - a) Jumlah Ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) Pra hamil atau pada Trimester 1 (< 12 minggu) kurang dari 18,5 kg/m² yang mendapatkan makanan tambahan (penyuluhan atau pemulihan) sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
 - b) Jumlah Ibu hamil kurang energi kronis (KEK) yang mempunyai ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm yang mendapatkan makanan tambahan (penyuluhan atau pemulihan) sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
 - c) Jumlah Balita berat badan tidak naik (1 T) dengan atau tanpa stunting yang mendapatkan makanan tambahan (penyuluhan atau pemulihan) sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
 - d) Jumlah Balita berat badan kurang, dengan atau tanpa stunting yang mendapatkan makanan tambahan (penyuluhan atau pemulihan) sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
 - e) Jumlah Balita gizi kurang, dengan atau tanpa stunting yang mendapatkan makanan tambahan (penyuluhan atau pemulihan) sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
- d. Pelayanan Rujukan Kasus Balita Stunting.

Jika didapatkan anak dengan PB atau TB berdasarkan usia dan jenis kelamin <-2 SD, BB/U $<- 2$ SD, kenaikan berat tidak memadai dan perlambatan pertumbuhan linier, maka anak tersebut harus dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau puskesmas.

Dokter melakukan konfirmasi pengukuran antropometri terlebih dahulu sebelumnya dan penelusuran penyebab potensial stunting. Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dilakukan pemeriksaan

penunjang dasar yang tersedia seperti pemeriksaan darah rutin, urinalisis, feses rutin dan tes Mantoux.

Jika teridentifikasi ada penyebab medis atau komplikasi yang mendasari dan tidak ada respon yang adekuat pada penatalaksanaan dengan Pangan olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK) selama 1 (satu) pekan, maka balita dirujuk ke dokter spesialis anak di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

1) Tujuan Umum

Penguatan peran lintas sektor dalam menemukan dan merujuk balita stunting

2) Tujuan Khusus

Terujuknya semua balita stunting, baik rujukan pertama ke FKTP maupun rujukan sekunder ke FKRTL. Rujukan dilakukan oleh petugas kesehatan atau dokter sesuai kewenangannya ke fasilitas kesehatan di tingkat yang lebih tinggi.

3) Sasaran

a) Balita yang terkonfirmasi stunting di tingkat masyarakat dan FKTP yang perlu mendapatkan rujukan penanganan lebih lanjut.

b) Pendamping balita

c) Petugas kesehatan pendamping

4) Pelaksana Kegiatan

a) Dinas Kesehatan Provinsi

b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

c) Puskesmas dan Petugas Kesehatan.

5) Keluaran

Jumlah balita stunting yang mendapatkan pelayanan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.

e. Fasilitasi Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil

1) Tujuan Umum

Meningkatkan akses ibu hamil dan keluarga ke kelas ibu hamil

2) Tujuan Khusus

a) Perubahan perilaku kesehatan dan gizi ibu hamil dan keluarga

b) Meningkatkan cakupan kelas ibu hamil

(3) Sasaran

Ibu hamil dan keluarga

- (4) Pelaksana Kegiatan
 - a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - b) Puskesmas dan Petugas Kesehatan.
- (5) Keluaran
 - a) Jumlah frekwensi kegiatan penyelenggaraan kelas ibu hamil (paling sedikit 1x sebulan)
 - b) Jumlah ibu dan keluarga yang mendapatkan edukasi
- f. Fasilitasi Pelaksanaan Kelas Ibu Balita
 - 1) Tujuan Umum

Pemberian informasi kesehatan balita dan pemantauan perkembangan balita dalam rangka percepatan penurunan stunting
 - 2) Tujuan Khusus
 - a) Pemberian informasi mengenai cara menilai pertumbuhan balita yang baik, gizi balita, mencegah gangguan pertumbuhan pada balita
 - b) Pemberian informasi mengenai cara menilai perkembangan balita sesuai usianya, stimulasi dan deteksi dini gangguan perkembangan balita
 - 3) Sasaran

Ibu dengan balita, pengasuh balita, keluarga yang memiliki balita
 - 4) Pelaksana Kegiatan
 - a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - b) Puskesmas dan Petugas Kesehatan.
 - 5) Keluaran
 - a) Jumlah frekwensi kegiatan penyelenggaraan kelas ibu balita.
 - b) Jumlah ibu dan pengasuh balita yang mendapatkan edukasi
- g. Fasilitasi Penyelenggaraan Gerakan Pencegahan Stunting
 - 1) Tujuan Umum

Penyelenggaraan Gerakan Pencegahan Stunting (Aksi Bergizi, Bumi I Sehat, ABCDE Cegah Stunting Itu Penting, dan atau Gerakan Pencegahan Stunting lainnya)
 - 2) Tujuan Khusus
 - a) Meningkatkan perilaku peserta didik tentang pentingnya sarapan sehat, aktivitas fisik, minum Tablet Tambah Darah, edukasi kesehatan dan gizi secara rutin.
 - b) Meningkatkan perilaku ibu hamil tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali di fasilitas kesehatan terd

ekat, rutin mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) rutin.

- c) Peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang stunting dan pencegahannya (Aktif minum Tablet Tambah Darah, Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali, Cukupi konsumsi protein hewani, Datang ke Posyandu setiap bulan, Eksklusif ASI 6 bulan)

3) Sasaran

- a) Remaja putri di SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat, warga sekolah
- b) Ibu Hamil, keluarga
- c) Masyarakat umum

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c) Puskesmas dan Petugas Kesehatan.

5) Keluaran

Jumlah frekwensi kegiatan penyelenggaraan Gerakan Pencegahan Stunting (Aksi Bergizi, Bumil Sehat, ABCDE Cegah Stunting Itu Penting dan atau Gerakan Pencegahan Stunting lainnya).

h. Pelayanan Rujukan Kasus Balita Dengan Gangguan Perkembangan

1) Tujuan Umum

Penguatan peran lintas sektor dalam menemukan dan merujuk balita dengan gangguan perkembangan

2) Tujuan Khusus

Terujuknya seluruh balita yang dideteksi dengan gangguan perkembangan agar mendapatkan tatalaksana sesuai dengan aturan yang berlaku

3) Sasaran

- a) Balita yang dengan gangguan perkembangan yang ditemukan di tingkat masyarakat dan FKTP yang perlu mendapatkan rujukan penanganan lebih lanjut
- b) Pendamping balita
- c) Petugas kesehatan pendamping

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- b) Puskesmas

- c) Dokter
- d) Petugas Kesehatan
- 5) Keluaran

Jumlah balita dengan gangguan perkembangan yang mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan lebih tinggi.

3. Peningkatan Cakupan Vaksinasi dan Imunisasi

Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh (melalui suntikan, oral, atau tetes) untuk merangsang system kekebalan agar mengenali dan melawan pathogen tertentu (seperti virus atau bakteri). Vaksinasi berfokus pada Tindakan fisik atau prosedur memberikan vaksin. Imunisasi adalah proses tubuh membentuk kekebalan (antibody) terhadap suatu penyakit, baik melalui vaksinasi atau paparan alami terhadap penyakit tersebut. Imunisasi berfokus pada hasil akhir (kekebalan tubuh), terlepas dari cara mendapatkannya.

Program imunisasi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah berbagai penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Beberapa penyakit yang termasuk dalam PD3I adalah tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, polio, hepatitis B, diare rotavirus, cacar, rubella, campak, meningitis, dan pneumonia.

Manfaat utama dari program imunisasi meliputi:

- a. Melindungi tubuh: Mencegah bayi dan anak dari serangan virus atau bakteri penyebab penyakit tertentu.
- b. Membentuk kekebalan kelompok (herd immunity): Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata dapat melindungi kelompok masyarakat yang rentan.
- c. Mengurangi kecemasan: Mengurangi kekhawatiran anak dan orang tua terhadap tertularnya suatu penyakit.
- d. Meningkatkan status kesehatan: Meningkatkan kesehatan dan tumbuh kembang bayi dan anak.
- e. Meningkatkan produktivitas: Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Peningkatan Cakupan Vaksinasi dan Imunisasi:

a. Peningkatan Pelayanan Cakupan Vaksinasi Dan Imunisasi

1) Tujuan Umum

Terlaksananya pelayanan vaksinasi dan imunisasi rutin dengan cakupan yang tinggi dan merata

- 2) Tujuan Khusus
 - a) Terdistribusinya vaksin dan logistik imunisasi rutin ke setiap puskesmas dengan baik.
 - b) Terlaksananya pelayanan vaksinasi dan imunisasi bayi, anak baduta (bawah 2 tahun), anak usia sekolah, Wanita usia subur.
 - c) Terlaksananya sweeping vaksinasi dan imunisasi bagi sasaran yang belum lengkap imunisasinya
- 3) Sasaran
Bayi, baduta, anak usia sekolah, wanita usia subur dan masyarakat
- 4) Pelaksana Kegiatan
 - a) Dinas Kesehatan Provinsi
 - b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - c) Puskesmas
 - d) Pengelola dan Pelaksana Vaksinasi dan Imunisasi Puskesmas Posyandu dan Pos Imunisasi
- 5) Keluaran
 - a) Jumlah frekwensi pengiriman vaksin dan logistic dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas dan atau pengambilan vaksin dan logistic imunisasi ke Provinsi.
 - b) Jumlah Bayi, anak baduta, anak usia sekolah, Wanita usia subur dan masyarakat dilayani vaksinasi dan Imunisasi
- b. Pengelolaan imunisasi Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK).

Dalam surat edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.02/C/5961/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang penggunaan Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) untuk Imunisasi Rutin ditetapkan bahwa pencatatan dan pelaporan kegiatan imunisasi rutin menggunakan Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) sejak tanggal 1 Januari 2023 dan harus dilaksanakan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

ASIK adalah aplikasi terpusat yang digunakan untuk input dan monitoring data perkembangan pasien/peserta program untuk seluruh tenaga kesehatan layanan Primer. Salah satu monitoring yakni layanan imunisasi rutin untuk melakukan pencatatan imunisasi rutin yang diberikan langsung maupun riwayat imunisasi pada bayi, baduta, anak sekolah dasar, dan Wanita Usia Subur (WUS).

Petugas pelaksana imunisasi (vaksinator) adalah petugas yang bertugas memberikan layanan imunisasi kepada masyarakat yang

menjadi sasaran baik di Puskesmas maupun di pos imunisasi, posyandu yang berada di wilayah kerja puskesmas. Selain memberikan layanan imunisasi petugas ini juga mencatat dan melaporkan hasil layanannya melalui ASIK mobile pada handphone petugas tersebut. Selama ini keluhan petugas salah satunya adalah tidak ada biaya pulsa atau paket data khusus untuk penginputan data tersebut melalui ASIK mobile. Sehingga akibatnya penginputan hasil layanan imunisasi menjadi tidak optimal.

1) Tujuan Umum

Terlaksananya pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Imunisasi secara tepat waktu (*real time*)

2) Tujuan Khusus

a) Tersedianya data hasil pelaksanaan imunisasi real time meliputi sasaran, target dan cakupan pelaksanaan imunisasi dan tersedianya Informasi Hasil Cakupan Imunisasi mulai dari Tingkat Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Tingkat Provinsi dan Kementerian Kesehatan

b) Terekamnya data individu hasil layanan imunisasi yang diinput oleh pengelola dan pelaksana vaksinasi dan imunisasi melalui ASIK mobile di puskesmas, posyandu dan pos imunisasi

3) Sasaran

Puskesmas, Posyandu dan Pos Imunisasi

4) Pelaksana Kegiatan

a) Dinas Kesehatan Provinsi

b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

c) Puskesmas

d) Pengelola dan Pelaksana Vaksinasi dan Imunisasi Puskesmas Posyandu dan Pos Imunisasi

5) Keluaran

Jumlah paket data untuk petugas pelaksana pelayanan vaksinasi dan imunisasi kegiatan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Imunisasi secara tepat waktu (*real time*)

4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah (5) lima tahun

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah (5) lima tahun :

- a. Sosialisasi Percepatan Program Layanan Unggulan Pengampuan Kesehatan Ibu Anak (KIA) di Jejaring Pengampuan Layanan Unggulan KIA
 - 1) Tujuan Umum

Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan di puskesmas dan rumah sakit dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan dan sistem rujukan kesehatan ibu dan anak melalui pendampingan.
 - 2) Tujuan Khusus
 - a) Terlaksananya pendampingan oleh tim layanan unggulan KIA kepada jejaring di puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD) dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan dan sistem rujukan kesehatan ibu dan anak.
 - b) Memberikan salah satu upaya penurunan trend jumlah kematian ibu, bayi dan balita di wilayah puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
 - 3) Sasaran
 - a) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jejaring Pengampuan Layanan Unggulan KIA
 - b) Puskesmas Jejaring Pengampuan Layanan Unggulan KIA
 - 4) Pelaksana Kegiatan
 - a) Dinas Kesehatan Provinsi
 - b) Dinas Kesehatan Kab/Kota

Pelaksana kegiatan berkolaborasi dengan Tim Pengampuan Layanan Unggulan KIA.
 - 5) Keluaran
 - a) Jumlah frekwensi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan KIA di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
 - c) Jumlah paket pelaksanaan kegiatan pendampingan kualitas pelayanan KIA di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jejaring Pengampuan Layanan Unggulan KIA
- b. Sosialisasi/Advokasi dan Orientasi Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.
 - 1) Tujuan Umum

Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan untuk implementasi dan peningkatan cakupan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang berkualitas dalam membantu

percepatan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Stunting.

2) Tujuan Khusus

- a) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sesuai standar.
- b) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi calon pengantin sesuai standar tentang pentingnya Pemeriksaan Kesehatan
- c) Meningkatkan dukungan lintas program dan lintas sektor di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi calon pengantin
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin di Kabupaten/Kota

3) Sasaran

- a) Pemangku kebijakan dan pihak terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b) Pelaksana pelayanan kesehatan bagi calon pengantin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan primer
- c) Pengelola program kesehatan reproduksi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- d) Calon pengantin
- e) Masyarakat

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- b) Puskesmas
- c) Pengelola Program Kesehatan Reproduksi Kabupaten/Kota

5) Keluaran

- a) Jumlah frekwensi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi/Advokasi dan Orientasi Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin bagi Pemangku kebijakan dan pihak terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan calon pengantin.
- b) Jumlah orang calon pengantin mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan di kabupaten/kota

c. Pelayanan Skrining, Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi dan Balita serta Rujukan Test Konfirmasi Skrining Bayi Baru Lahir

Sebagai salah satu upaya penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup anak, upaya preventif merupakan hal yang strategis dan

cost-effective. Upaya preventif dapat dilakukan melalui skrining bayi baru lahir untuk deteksi dini kelainan bawaan pada bayi baru lahir serta mencegah keterlambatan mendapatkan pengobatan. Pelaksanaan skrining bayi baru lahir meliputi Skrining Hipotoroid Kongenital (SHK), Skrining Hiperplasia Adrenal Kongenital (S-HAK), Skrining Defisiensi G6PD (S-G6PD), Skrining Penyakit Jantung Bawaan Kritis (PJB Kritis) dan skrining kelainan saluran empedu.

Khusus untuk skrining yang memerlukan pemeriksaan darah di laboratorium (SHK, S-HAK, SG6PD), komponen pembiayaannya terdiri dari biaya jasa pemeriksaan sampel di laboratorium rujukan, biaya tes konfirmasi di laboratorium rujukan atau laboratorium lainnya, biaya pengiriman sampel dari fasilitas kesehatan ke laboratorium rujukan, dan biaya bahan medis habis pakai skrining bayi baru lahir.

- 1) Tujuan Umum
Meningkatkan cakupan skrining Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi dan Balita serta Rujukan Test Konfirmasi Skrining Bayi Baru Lahir sesuai standar teknis yang ditetapkan Kementerian Keuangan
- 2) Tujuan Khusus
 - a) Terlaksananya pelayanan pemeriksaan skrining, pemantauan pertumbuhan bayi dan balita
 - b) Terlaksananya pelayanan rujukan Test Konfirmasi bayi ba ibu hamil, bayi dan balita
- 3) Sasaran
 - a) Bayi
 - b) Balita
 - c) Bayi baru lahir dengan hasil skrining positif yang membutuhkan tes konfirmasi
- 4) Pelaksana Kegiatan
 - a) Dinas Kesehatan Kab/Kota
 - b) Puskesmas
 - c) Petugas kesehatan pendamping
 - d) Pendamping bayi
- 5) Keluaran
 - a) Jumlah bayi, dan balita yang mendapatkan pelayanan skrining, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan

- b) Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan rujukan untuk tes konfirmasi
- d. Pendampingan Ibu Dan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Antenatal Dan Postnatal
 - 1) Tujuan Umum

Mendekatkan akses pelayanan antenatal dan postnatal (kunjungan nifas dan kunjungan neonatal ke fasilitas pelayanan kesehatan melalui peran aktif dan pemberdayaan masyarakat
 - 2) Tujuan Khusus
 - a) Meningkatkan cakupan pelayanan antenatal dan post natal (K1, ANC 6x, KF, dan KN)
 - b) Meningkatkan akses pelayanan antenatal dan postnatal pada ibu dan bayi baru lahir tidak memiliki jaminan kesehatan
 - c) Meningkatkan jumlah ibu hamil memiliki Buku KIA melalui kegiatan penyediaan
 - 3) Sasaran
 - a) Ibu hamil
 - b) Ibu nifas
 - c) Bayi baru lahir
 - 4) Pelaksana Kegiatan
 - a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - b) Puskesmas
 - c) Tenaga kesehatan di FKTP bermitra dengan Kader, PKK dan Dukun/Paraji (jika masih ada
 - 5) Keluaran
 - a) Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal 6x di fasilitas pelayanan kesehatan melalui akses mitra
 - b) Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan kunjungan neonatal di fasilitas pelayanan kesehatan melalui akses mitra
 - c) Jumlah ibu hamil yang memiliki buku KIA
- 5. Penanggulangan dan Penanganan Penyakit Paru, Saluran Pernapasan, dan Kanker Akibat Merokok

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Penanggulangan dan penanganan penyakit paru, saluran pernapasan, dan kanker akibat merokok dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Advokasi dan Sosialisasi Kegiatan Deteksi Dini Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)

1) Tujuan Umum

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang penyakit PPOK, serta mendorong upaya deteksi dini dan penanganan yang tepat kepada berbagai kalangan pimpinan instansi/institusi, masyarakat umum, pekerja, dan mahasiswa.

2) Tujuan Khusus

- a) Menambah pengetahuan tentang PPOK, faktor risiko, gejala, dan pentingnya deteksi dini.
- b) Meningkatkan kesadaran akan dampak PPOK terhadap produktivitas dan kualitas hidup.
- c) Memotivasi pimpinan instansi untuk mendukung program deteksi dini PPOK di lingkungan kerja.
- d) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung kegiatan deteksi dini.

3) Sasaran

- a) Pimpinan instansi: Kepala dinas, direktur perusahaan, rektor perguruan tinggi, dan pimpinan organisasi lainnya.
- b) Masyarakat umum: Warga masyarakat di berbagai wilayah, terutama kelompok berisiko tinggi (perokok, pekerja di lingkungan berdebu).
- c) Pekerja: Karyawan di berbagai sektor industri, terutama yang terpapar risiko lingkungan kerja yang dapat memicu PPOK.
- d) Mahasiswa: Mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, terutama kesehatan masyarakat dan terkait.

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

5) Keluaran

Jumlah frekwensi pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Kegiatan Deteksi Dini Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)

b. Kampanye dan Edukasi Pencegahan PPOK;

1) Tujuan Umum

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit PPOK, mendorong perubahan perilaku sehat untuk mencegah PPOK, dan menurunkan angka kejadian PPOK di masyarakat.

2) Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PPOK, faktor risiko, gejala, dan komplikasi.
- b) Membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan paru-paru dan mencegah PPOK.
- c) Mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku sehat, seperti berhenti merokok, menghindari paparan polusi udara, dan melakukan aktivitas fisik.
- d) Membangun dukungan sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat.
- e) Perubahan perilaku: Terjadi peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku sehat pada masyarakat sasaran.

3) Sasaran

- a) Masyarakat umum: Khususnya kelompok berisiko tinggi seperti perokok, pekerja di lingkungan berdebu, dan orang dengan riwayat keluarga PPOK.
- b) Remaja dan pemuda: Sebagai upaya pencegahan sejak dini.
- c) Komunitas: Kelompok masyarakat, RT/RW, desa, atau komunitas berbasis minat.

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

5) Keluaran

Jumlah frekwensi pelaksanaan Kampanye dan Edukasi Pencegahan PPOK

c. Deteksi Dini PPOK Di Masyarakat dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

1) Tujuan Umum

Meningkatkan cakupan deteksi dini PPOK di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat dan dini pada penderita PPOK.

2) Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan tenaga kesehatan tentang pentingnya deteksi dini PPOK.
- b) Mempermudah akses masyarakat terhadap pemeriksaan deteksi dini PPOK.
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan deteksi dini PPOK di fasilitas kesehatan.

- d) Menemukan kasus PPOK pada tahap awal sehingga dapat dilakukan penanganan yang lebih efektif.
 - e) Peningkatan pengetahuan: Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan tenaga kesehatan tentang PPOK dan deteksi dini.
 - f) Peningkatan akses: Tersedianya layanan deteksi dini PPOK di lebih banyak fasilitas kesehatan.
 - g) Ditemukannya kasus baru: Terdeteksinya kasus PPOK baru pada tahap awal.
 - h) Peningkatan kualitas pelayanan: Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk deteksi dini PPOK di fasilitas kesehatan.
 - i) Terkumpulnya data kasus PPOK untuk monitoring dan evaluasi.
- 3) Sasaran
- a) Masyarakat umum: Khususnya kelompok berisiko tinggi seperti perokok, pekerja di lingkungan berdebu, dan orang dengan riwayat keluarga PPOK.
 - b) Tenaga kesehatan: Dokter umum, perawat, bidan, dan petugas kesehatan lainnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
 - c) Fasilitas pelayanan kesehatan: Puskesmas, klinik, dan rumah sakit.
- 4) Pelaksana Kegiatan
- a) Dinas Kesehatan Provinsi
 - b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- 5) Keluaran
- Jumlah frekwensi pelaksanaan Deteksi dini PPOK di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan
- d. Manajemen kasus PPOK dan Asma Terpadu di Puskesmas;
- 1) Tujuan Umum
Meningkatkan kualitas hidup penderita PPOK dan asma melalui pengelolaan kasus yang terpadu dan berkelanjutan di tingkat Puskesmas maupun di Masyarakat.
 - 2) Tujuan Khusus
 - a) Membantu penderita mencapai kontrol gejala yang optimal.
 - b) Mengurangi frekuensi dan keparahan serangan akut.
 - c) Meningkatkan kualitas hidup penderita dan produktivitas.
 - d) Mencegah terjadinya komplikasi yang serius.

- e) Peningkatan kontrol gejala: Berkurangnya frekuensi dan intensitas gejala pada penderita.
 - f) Penurunan angka eksaserbasi:
 - g) Berkurangnya jumlah serangan akut.
 - h) Peningkatan kualitas hidup: Peningkatan skor kualitas hidup yang dilaporkan penderita.
 - i) Peningkatan kepatuhan pengobatan: Peningkatan kepatuhan penderita dalam mengonsumsi obat.
 - j) Penderita TB mendapatkan pemberian makanan tambahan
 - k) Terbentuknya register pasien: Tersedianya data yang lengkap mengenai pasien PPOK dan asma.
- 3) Sasaran
- a) Penderita PPOK dan Asma: Pasien yang telah terdiagnosis PPOK dan asma.
 - b) Tenaga kesehatan: Dokter umum, perawat, dan bidan di puskesmas.
 - c) Keluarga penderita: Anggota keluarga yang berperan dalam perawatan penderita
- 4) Pelaksana Kegiatan
- a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - b) Puskesmas
- 5) Keluaran
- a) Jumlah frekwensi pelaksanaan kegiatan manajemen kasus PPOK dan Asma Terpadu di Puskesmas
 - b) Jumlah penderita TB mendapatkan pemberian makanan tambahan
6. Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi dan Resistensi Antimikroba
- Salah satu upaya dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu dengan menyusun Program PPI yang merupakan salah satu komponen penting dalam menjamin pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Program PPI disusun sebagai upaya dalam mencegah terjadinya infeksi yang merupakan risiko utama bagi pasien dan petugas kesehatan. Infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas, biaya pengobatan dan penggunaan agen antimikroba, sehingga meningkatkan potensi kejadian resistensi antimikroba.
- a. Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi (PPI)

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (Health Care Associated Infections) yang selanjutnya disingkat HAIs adalah infeksi yang terjadi saat pasien mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mana saat masuk tidak dalam masa inkubasi infeksi tersebut termasuk infeksi muncul setelah pasien pulang dan infeksi yang terjadi pada petugas akibat pekerjaannya. Pelaksanaan program PPI di Puskesmas dilaksanakan oleh Tim PPI

b. Pencegahan dan Penanggulangan Resistensi Antimikroba.

Penyalahgunaan dan penggunaan antimikroba yang berlebihan pada manusia menjadi pendorong utama berkembangnya patogen resisten terhadap obat. Bahaya resistensi antimikroba berkaitan erat dengan perilaku pencegahan dan pengobatan, sistem keamanan produksi pangan dan lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan resistensi antimikroba melalui pengawasan sanitasi *hygiene* dan penggunaan antibiotik yang bijak.

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi dan Resistensi Antimikroba:

a. Sosialisasi Penggunaan Antibiotika Rasional

1) Tujuan Umum

Meningkatkan pengetahuan Dinkes Provinsi, Kab/Kota dan Puskesmas terkait Pencegahan dan Penanggulangan Resistensi Antimikroba.

2) Tujuan Khusus

a) Meningkatkan pemahaman terkait Resistensi Antimikroba.

b) Meningkatkan pemahaman terkait Pencegahan dan Penanggulangan Resistensi Antimikroba

3) Sasaran

Petugas Pengelola surveilans Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

4) Pelaksana Kegiatan

a) Dinas Kesehatan Provinsi

b) Dinas Kesehatan Kab/Kota

c) Puskesmas

5) Keluaran

Jumlah paket kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Penggunaan Antibiotika Rasional

b. Pertemuan Koordinasi Surveilans Resistance Antimikroba.

1) Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kejadian resistance antimikroba di Puskesmas

2) Tujuan Khusus

a) Meningkatkan upaya penurunan kejadian resistance antimikroba di Puskesmas

b) Menyusun upaya perbaikan program resistance antimikroba untuk penurunan kejadian resistance antimikroba di Puskesmas dan tersusunnya kebijakan dalam upaya penanggulangan resistensi antimikroba di Puskesmas

3) Sasaran

Tim Pengelola surveilans Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas

4) Pelaksana Kegiatan

a) Dinas Kesehatan Provinsi

b) Dinas Kesehatan Kab/Kota

c) Puskesmas

5) Keluaran

Jumlah paket kegiatan pelaksanaan Pertemuan koordinasi surveilans resistance antimikroba

B. Penyediaan/Peningkatan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dapat diberikan kepada masyarakat terpenuhi, salah satu prasyaratnya bilamana fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, ketersediaan peralatan kesehatan, alat penunjang medik dan ketersediaan farmasi yang aman dan laik pakai. Hal ini tidak saja mendukung pelayanan yang berkualitas tapi juga akan mengurangi rujukan yang tidak perlu dengan alasan masalah sarana dan prasarana. Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memenuhi persyaratan pada ketersediaan sarana, prasarana peralatan kesehatan, alat penunjang medik dan ketersediaan farmasi sesuai standar, merupakan faktor penting di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.

Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah daerah menggunakan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang selanjutnya disingkat ASPAK, sebagai suatu aplikasi berbasis web yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan :

1. Pengadaan.

a. Pengadaan Obat-Obatan, Bahan Medis Habis Pakai, Bahan Kimia dan /Atau Reagen

1) Tujuan Umum

Memenuhi kebutuhan obat-obatan, bahan medis habis pakai, bahan kimia dan/atau reagen untuk mendukung pelayanan yang berkualitas pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.

2) Tujuan Khusus

Terpenuhi kebutuhan obat-obatan, bahan medis habis pakai, bahan kimia, reagen dan distribusi untuk mendukung pelayanan yang berkualitas pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi dan Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

3) Sasaran

- a) Rumah Sakit Umum Daerah
- b) Rumah Sakit Khusus
- c) Puskesmas
- d) Unit Transfusi Darah
- e) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah
- f) Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota
- g) Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)
- h) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c) Rumah Sakit Umum Daerah
- d) Rumah Sakit Khusus

5) Keluaran

- a) Jumlah paket pengadaan Obat-obatan
 - b) Jumlah paket pengadaan bahan medis habis pakai
 - c) Jumlah paket pengadaan bahan kimia dan /atau reagen
- b. Pengadaan Alat Kesehatan
- 1) Tujuan Umum
Memenuhi kebutuhan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan yang berkualitas pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.
 - 2) Tujuan Khusus
Terpenuhi kebutuhan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan yang berkualitas pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
 - 3) Sasaran
 - a) Rumah Sakit Umum Daerah
 - b) Rumah Sakit Khusus
 - c) Puskesmas
 - d) Unit Transfusi Darah
 - e) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah
 - f) Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota
 - g) Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)
 - h) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
 - 4) Pelaksana Kegiatan
 - a) Dinas Kesehatan Provinsi
 - b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - c) Rumah Sakit Umum Daerah
 - d) Rumah Saki Khusus
 - 5) Keluaran
Jumlah unit pengadaan alat kesehatan
- c. Pengadaan Sarana Transportasi Rujukan Berupa Ambulance
- 1) Tujuan Umum
Memenuhi kebutuhan sarana transportasi rujukan berupa ambulance, untuk mendukung pelayanan yang berkualitas pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.

2) Tujuan Khusus

Terpenuhinya kebutuhan sarana transportasi rujukan berupa ambulance sesuai pedoman spesifikasi teknis yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, untuk mendukung pelayanan yang berkualitas pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

3) Sasaran

- a) Rumah Sakit Umum Daerah
- b) Rumah Sakit Khusus
- c) Puskesmas
- d) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c) Rumah Sakit Umum Daerah
- d) Rumah Sakit Khusus

5) Keluaran

Jumlah unit pengadaan ambulance

d. Pengadaan Sarana Operasional yang Dapat Dipindahkan Untuk Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif Dan Preventif.

1) Tujuan Umum

Memenuhi kebutuhan sarana operasional yang dapat dipindahkan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.

2) Tujuan Khusus

- a) Terpenuhi kebutuhan sarana operasional yang dapat dipindahkan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif berupa Mobil Penyuluhan (*Mobil Health Promotion*) berpedoman pada spesifikasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan untuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota berpedoman pada spesifikasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan
- b) Peralatan multimedia penyuluhan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah : Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah,

Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi milik pemerintah daerah milik pemerintah daerah, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

3) Sasaran

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c) Puskesmas
- d) Rumah Sakit Umum Daerah
- e) Rumah Sakit Khusus
- f) Unit Transfusi Darah
- g) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah
- h) Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota
- i) Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)
- j) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c) Rumah Sakit Umum Daerah
- d) Rumah Sakit Khusus

5) Keluaran

- a) Jumlah unit pengadaan Mobil penyuluhan (*Mobil Health Promotion*) untuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- e) Jumlah unit pengadaan Peralatan multimedia penyuluhan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah : Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi milik pemerintah daerah milik pemerintah daerah, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

2. Pembangunan Baru.

1) Tujuan Umum

Pemenuhan sarana bangunan dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah melalui pembangunan baru, sesuai dengan rasio kebutuhan.

2) Tujuan Khusus

Terpenuhinya kebutuhan sarana bangunan dan parasarana fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

3) Sasaran

- a) Rumah Sakit Umum Daerah.
- b) Rumah Sakit Khusus.
- c) Puskesmas.
- d) Unit Transfusi Darah
- e) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah.
- f) Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota
- g) Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)
- h) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c) Rumah Sakit Umum Daerah
- d) Rumah Sakit Khusus

5) Keluaran

Jumlah unit pembangunan sarana bangunan dan parasarana fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

3. Penambahan Ruang.

1) Tujuan Umum

Pemenuhan kebutuhan sarana bangunan dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah melalui penambahan ruang untuk meningkatkan kapasitas utilitas pelayanan kesehatan.

2) Tujuan Khusus

Pemenuhan kebutuhan sarana bangunan dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi milik

pemerintah daerah, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya melalui penambahan ruang.

3) Sasaran

- a) Rumah Sakit Umum Daerah
- b) Rumah Sakit Khusus
- c) Puskesmas.
- d) Unit Transfusi Darah
- e) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah.
- f) Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota
- g) Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)
- h) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c) Rumah Sakit Umum Daerah
- d) Rumah Sakit Khusus

5) Keluaran

Jumlah unit penambahan ruang fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi milik pemerintah daerah, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya melalui penambahan ruang.

4. Rehabilitasi Bangunan.

1) Tujuan Umum

Rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki sarana bangunan dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang rusak sebagian yang bertujuan agar tetap dapat digunakan sesuai fungsinya.

2) Tujuan Khusus

Terlaksananya rehabilitasi untuk memperbaiki sarana bangunan dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi milik pemerintah

daerah, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

3) Sasaran

- a) Rumah Sakit Umum Daerah
- b) Rumah Sakit Khusus
- c) Puskesmas
- d) Unit Transfusi Darah
- e) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah
- f) Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota
- g) Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)
- h) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c) Rumah Sakit Umum Daerah
- d) Rumah Sakit Khusus

5) Keluaran

Jumlah unit rehabilitasi bangunan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi milik pemerintah daerah, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

5. Pemeliharaan Bangunan/Peralatan.

1) Tujuan Umum

Pemeliharaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keandalan sarana bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dalam keadaan laik fungsi.

2) Tujuan Khusus

Pemeliharaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keandalan sarana bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah dan Instalasi Farmasi, Unit Pelayanan

Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya agar dalam keadaan laik fungsi.

- 3) Sasaran
 - a) Rumah Sakit Umum Daerah.
 - b) Rumah Sakit Khusus.
 - c) Puskesmas.
 - d) Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 - e) Unit Transfusi Darah
 - f) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah.
 - g) Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota
 - h) Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)
 - i) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- 4) Pelaksana Kegiatan
 - a) Dinas Kesehatan Provinsi
 - b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - c) Rumah Sakit Umum Daerah
 - d) Rumah Sakit Khusus
- 5) Keluaran
 - a) Jumlah unit pemeliharaan sarana bangunan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah dan Instalasi Farmasi, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
 - b) Jumlah unit pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah dan Instalasi Farmasi, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
 - c) Jumlah unit Pemeliharaan peralatan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah

dan Instalasi Farmasi, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

6. Kalibrasi/Sertifikasi/Akreditasi.

Kalibrasi sebagai kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur. Pengujian sebagai keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. Kalibrasi/sertifikasi dilaksanakan oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan UPTD Kementerian Kesehatan, Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan UPTD Daerah dan Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan. Alat kesehatan yang dilakukan Pengujian dan/atau Kalibrasi merupakan peralatan yang digunakan untuk keperluan diagnosa, terapi, rehabilitasi dan penelitian medik baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki parameter penunjukan, keluaran, atau kinerja.

Akreditasi merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah, melalui penilaian bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut telah memenuhi standar akreditasi. Standar akreditasi sebagai pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Tahapan kegiatan akreditasi terdiri tahap persiapan akreditasi, tahap pelaksanaan akreditasi dan tahap pasca akreditasi.

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan Kalibrasi/Sertifikasi/Akreditasi :

a. Kalibrasi/sertifikasi

1) Tujuan Umum

Menjamin tersedianya Alat Kesehatan yang sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah daerah.

2) Tujuan Khusus

Terlaksananya kalibrasi/sertifikasi Alat Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi milik pemerintah daerah, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K), dan fasilitas kesehatan lainnya.

3) Sasaran

- a) Rumah Sakit Umum Daerah
 - b) Rumah Sakit Khusus
 - c) Puskesmas
 - d) Unit Transfusi Darah
 - e) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah.
 - f) Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota
 - g) Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)
 - h) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
- 4) Pelaksana Kegiatan
- a) Dinas Kesehatan Provinsi
 - b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - c) Rumah Sakit Umum Daerah
 - d) Rumah Sakit Khusus

5) Keluaran

Jumlah unit alat kesehatan yang di Kalibrasi/Sertifikasi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi milik pemerintah daerah, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K), dan fasilitas kesehatan lainnya.

b. Akreditasi

1) Tujuan Umum

Akreditasi untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan dan tata kelola organisasi dan pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.

2) Tujuan Khusus

Terlaksananya akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas kesehatan lainnya.

3) Sasaran

- a) Puskesmas
- b) Rumah Sakit Umum Daerah

- c) Rumah Sakit Khusus
- d) Unit Transfusi Darah
- e) Laboratorium Kesehatan Masyarakat
- f) Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)
- 4) Pelaksana Kegiatan
 - a) Dinas Kesehatan Provinsi
 - b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - c) Rumah Sakit Umum Daerah
 - d) Rumah Sakit Khusus
- 5) Keluaran
 - a) Jumlah unit fasilitas pelayanan kesehatan akreditasi tahap persiapan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas kesehatan lainnya.
 - b) Jumlah unit fasilitas pelayanan kesehatan akreditasi tahap pelaksanaan akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas kesehatan lainnya.
 - c) Jumlah unit fasilitas pelayanan kesehatan akreditasi tahap pasca akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan fasilitas kesehatan lainnya.

7. Pembelian Suku Cadang

1) Tujuan Umum

Pembelian suku cadang yang merupakan komponen dari peralatan kesehatan, penunjang medik dan prasarana yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian yang mengalami kerusakan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah agar dalam keadaan laik fungsi.

2) Tujuan Khusus

Terpenuhinya kebutuhan suku cadang pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi milik pemerintah daerah, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K), dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.

3) Sasaran

- a) Rumah Sakit Umum Daerah
- b) Rumah Sakit Khusus
- c) Puskesmas
- d) Unit Transfusi Darah
- e) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah
- f) Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota
- g) Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)
- h) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c) Rumah Sakit Umum Daerah
- d) Rumah Sakit Khusus

5) Keluaran

- a) Jumlah unit pembelian suku cadang peralatan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi milik pemerintah daerah, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K), dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- b) Jumlah unit pembelian suku cadang prasarana fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi milik pemerintah daerah, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K), dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.

C. Penyediaan/Peningkatan Sarana/Prasarana Fasilitas Sanitasi, Pengelolaan Limbah, Dan Air Bersih Pada Fasilitas Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dapat diberikan kepada masyarakat terpenuhi, salah satu prasyaratnya bilamana fasilitas pelayanan kesehatan didukung oleh ketersediaan sarana, dan prasarana fasilitas sanitasi, pengolahan limbah dan air bersih yang memenuhi persyaratan mendukung pelayanan yang berkualitas.

Sarana dan prasarana fasilitas sanitasi, pengolahan limbah dan air bersih pada fasilitas Pelayanan Kesehatan pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan sesuai standar merupakan faktor penting.

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih pada fasilitas kesehatan :

1. Pengadaan

1) Tujuan Umum

Pemenuhan kebutuhan prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah berfungsi baik.

2) Tujuan Khusus

Tersedianya prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

3) Sasaran

- a) Puskesmas
- b) Rumah Sakit Umum Daerah
- c) Rumah Sakit Khusus
- d) Unit Transfusi Darah
- e) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah
- f) Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota
- g) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c) Rumah Sakit Umum Daerah
- d) Rumah Sakit Khusus

5) Keluaran

- a) Jumlah unit pengadaan fasilitas sanitasi
- b) Jumlah unit pengadaan fasilitas pengelolaan limbah
- c) Jumlah unit pengadaan fasilitas air bersih

2. Pembangunan Baru

1) Tujuan Umum

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah berfungsi dengan baik

2) Tujuan Khusus

Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi an Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

3) Sasaran

- a) Puskesmas
- b) Rumah Sakit Umum Daerah
- c) Rumah Sakit Khusus
- d) Unit Transfusi Darah
- e) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah
- f) Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota.
- g) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c) Rumah Sakit Umum Daerah
- d) Rumah Sakit Khusus

5) Keluaran

- a) Jumlah unit pembangunan baru fasilitas sanitasi
- b) Jumlah unit pembangunan baru fasilitas pengelolaan limbah
- c) Jumlah unit pembangun baru fasilitas air bersih

3. Rehabilitasi

1) Tujuan Umum

Rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan yang

rusak sebagian yang rusak agar tetap dapat digunakan sesuai fungsinya.

2) Tujuan Khusus

Terlaksananya rehabilitasi fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang rusak sebagian.

3) Sasaran

- a) Puskesmas
- b) Rumah Sakit Umum Daerah
- c) Rumah Sakit Khusus
- d) Unit Transfusi Darah
- e) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah
- f) Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota
- g) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c) Rumah Sakit Umum Daerah
- d) Rumah Sakit Khusus

5) Keluaran

- a) Jumlah unit rehabilitasi fasilitas sanitasi
- b) Jumlah unit rehabilitasi fasilitas pengelolaan limbah
- c) Jumlah unit rehabilitasi fasilitas air bersih

4. Pemeliharaan

1) Tujuan Umum

Pemeliharaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keandalan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah agar dalam keadaan laik fungsi.

2) Tujuan Khusus

Terwujudnya pemeliharaan fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit

Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

3) Sasaran

- a) Puskesmas
- b) Rumah Sakit Umum Daerah
- c) Rumah Sakit Khusus
- d) Puskesmas Pembantu
- e) Unit Transfusi Darah
- f) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah
- g) Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota
- h) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c) Rumah Sakit Umum Daerah
- d) Rumah Sakit Khusus

5) Keluaran

- a) Jumlah unit pemeliharaan fasilitas sanitasi
- b) Jumlah unit pemeliharaan fasilitas pengelolaan limbah
- c) Jumlah unit pemeliharaan fasilitas air bersih

5. Pembelian Suku Cadang

1) Tujuan Umum

Pembelian suku cadang yang merupakan komponen dari mesin dan peralatan yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian yang mengalami kerusakan fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah agar dalam keadaan laik fungsi.

2) Tujuan Khusus

Terpenuhinya kebutuhan suku cadang yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih yang mengalami kerusakan pada pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

3) Sasaran

- a) Puskesmas

- b) Rumah Sakit Umum Daerah
- c) Rumah Sakit Khusus
- d) Unit Transfusi Darah
- e) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah
- f) Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota
- g) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
- 4) Pelaksana Kegiatan
 - a) Dinas Kesehatan Provinsi
 - b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - c) Rumah Sakit Umum Daerah
 - d) Rumah Sakit Khusus
- 5) Keluaran
 - a) Jumlah unit pembelian suku cadang fasilitas sanitasi
 - b) Jumlah unit pembelian suku cadang fasilitas pengelolaan limbah
 - c) Jumlah unit pembelian suku cadang fasilitas air bersih

D. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Termasuk Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial, untuk mengurangi risiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari biaya sendiri (*out of pocket*), dalam jumlah yang sulit diprediksi dan memerlukan biaya yang sangat besar, maka diperlukan suatu jaminan dalam bentuk asuransi kesehatan yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), karena peserta membayar premi dengan besaran tetap. Dengan demikian pembiayaan kesehatan ditanggung bersama secara gotong-royong oleh keseluruhan peserta, sehingga tidak memberatkan orang per orang.

JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Berikut ini adalah kegiatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja :

1) Tujuan Umum

Memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang melalui iuran dibayarkan oleh pemerintah daerah dengan penerima yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Tujuan Khusus

Pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang terdaftar oleh pemerintah daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja per orang selama 12 (dua belas) bulan.

3) Sasaran

- a) Pekerja bukan penerima upah
- b) Pekerja terkena pemutusan hubungan kerja
- c) Masyarakat petani tembakau
- d) Kader Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)
- e) Kader Posyandu Bidang Kesehatan
- f) Penyandang disabilitas

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Provinsi
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

5) Keluaran

- a) Jumlah orang dari pekerja bukan penerima upah
- b) Jumlah orang dari pekerja terkena pemutusan hubungan kerja
- c) Jumlah orang dari masyarakat petani tembakau
- d) Jumlah orang dari Kader Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)
- e) Jumlah orang dari Kader Posyandu Bidang Kesehatan
- f) Jumlah orang dari Penyandang disabilitas

E. Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Administratif Pada Fasilitas Kesehatan

Salah satu tantangan pelayanan kesehatan yaitu ketersediaan SDM kesehatan yang belum memenuhi standar, distribusi tenaga kesehatan belum merata dan kualitas SDM kesehatan, hal ini diperlukan pemecahan dengan upaya yang sesuai. Salah satu upayanya adalah peningkatan SDM kesehatan melalui pelatihan teknis topik prioritas dan penunjang.

Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kesehatan Dan/Atau Tenaga Administratif Pada Fasilitas Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tujuan Umum

Peningkatan kapasitas tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/pendukung kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) melalui pelatihan teknis prioritas dan penunjang.

2) Tujuan Khusus

- a) Terlaksananya pelatihan teknis prioritas bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait penurunan prevalensi penyakit akibat tembakau, topik prioritas (Gizi, KIA, intervensi layanan primer, P2P dan Kelompok Rentan) dan program kesehatan lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah dan Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K).
- b) Terlaksananya pelatihan penunjang tenaga penunjang/pendukung kesehatan terkait penurunan prevalensi penyakit akibat tembakau, topik prioritas (Gizi, KIA, intervensi layanan primer, P2P dan Kelompok Rentan) dan program kesehatan lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi dan Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K).

3) Sasaran

- a) Tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) milik pemerintah daerah.
- b) Tenaga penunjang/pendukung kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah ; Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, Instalasi Farmasi, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) milik pemerintah daerah.

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Lembaga pelatihan bidang kesehatan terakreditasi Kemenkes milik Kemenkes
 - b) Lembaga pelatihan bidang kesehatan terakreditasi Kemenkes milik Kementerian/Lembaga
 - c) Lembaga pelatihan bidang kesehatan terakreditasi Kemenkes milik pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 - d) Lembaga pelatihan bidang kesehatan terakreditasi
- 5) Keluaran
- a) Jumlah orang peserta pelatihan teknis prioritas Tenaga medis dan tenaga kesehatan
 - b) Jumlah orang peserta pelatihan teknis penunjang Tenaga penunjang/pendukung kesehatan

F. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Peran Kader.

Transformasi pelayanan kesehatan primer sebagai salah satu pilar dalam Transformasi Sistem Kesehatan difokuskan untuk meningkatkan pelayanan promotif dan preventif, seperti memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, promosi kesehatan, membangun infrastruktur, melengkapi sarana, prasarana, sumber daya manusia, serta memperkuat manajemen di seluruh pelayanan primer di tanah air khususnya Puskesmas. Transformasi pelayanan kesehatan primer yang akan dijalankan menerapkan konsep kewilayahan difokuskan pada pendekatan siklus hidup serta mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga ke tingkat dusun.

Peran Puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah di kecamatan membutuhkan dukungan Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K), agar masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan dan status kesehatan masyarakat dapat terpantau di seluruh wilayah kerjanya.

Pada penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di tingkat desa/kelurahan, peran Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) perlu diperkuat menjadi unit yang mampu pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Unit Pelayanan Kesehatan di desa/kelurahan minimal di laksanakan oleh kader kesehatan yang ditugasi oleh desa/kelurahan dan tenaga kesehatan. Sehingga perlu dilakukan penguatan termasuk di dalamnya untuk penempatan dan insentif kader dan Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan Posyandu bidang kesehatan.

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran kader :

1. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Bidang Kesehatan dan Kader Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K).

1) Tujuan Umum

Meningkatkan keterampilan dasar kader bidang kesehatan dalam melaksanakan pengelolaan posyandu bidang kesehatan dan Kader Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) pada pelayanan dasar bagi siklus hidup dalam kerangka integrasi pelayanan kesehatan primer.

2) Tujuan Khusus

- a) Melaksanakan pelatihan sesuai kurikulum Keterampilan Dasar Kader atau skenario pembelajaran dengan LMS.Kemkes.Go.Id Pelatihan Digital Keterampilan Kader
- b) Kader memiliki keterampilan dasar dan tenaga kesehatan mampu melaksanakan pembinaan teknis kesehatan bagi kader

3) Sasaran

- a) Kader Posyandu Bidang Kesehatan
- b) Kader Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)

4) Pelaksana Kegiatan

- a) Dinas Kesehatan Kab/Kota
- b) Puskesmas

5) Keluaran

- a) Jumlah orang Kader Posyandu Bidang Kesehatan mendapatkan pelatihan
- b) Jumlah orang Kader UPKD/K mendapatkan pelatihan

2. Pemberian Insentif Kader Posyandu Bidang Kesehatan dan Kader Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)

1) Tujuan Umum

Meningkatkan kesinambungan pengabdian Kader Posyandu bidang kesehatan dan Kader Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

2) Tujuan Khusus

Memberikan penghargaan berbasis kinerja bagi Kader Posyandu bidang kesehatan dan Kader Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)

3) Sasaran

- a) Kader Posyandu Bidang Kesehatan

- b) Kader Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)
- 4) Pelaksana Kegiatan
 - a) Dinas Kesehatan Kab/Kota
 - b) Puskesmas
- 5) Keluaran
 - a) Jumlah orang Kader Posyandu Bidang Kesehatan mendapat insentif
 - b) Jumlah orang Kader Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) mendapat insenti
- 3. Penempatan Kader Bidang Kesehatan.
 - 1) Tujuan Umum

Memenuhi kebutuhan kader di desa/kelurahan dengan sedikitnya 2 (dua) orang kader di Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K) dan sedikitnya 5 (lima) orang kader kesehatan per Posyandu
 - 2) Tujuan Khusus
 - a) Melaksanakan rekrutmen, menghasilkan surat keputusan penempatan Kader dan orientasi pra tugas bagi kader
 - b) Terlaksananya perekrutan kader dengan kesiapan pelaksanaan tugas bidang kesehatan di Posyandu dan Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)
 - 3) Sasaran

Masyarakat yang berdomisili di Desa/Kelurahan setempat yang memenuhi kriteria menjadi kader posyandu bidang dan kader Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)
 - 4) Pelaksana Kegiatan
 - a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - b) Puskesmas
 - 5) Keluaran
 - a) Jumlah orang Kader Posyandu Bidang Kesehatan
 - b) Jumlah orang Kader Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKD/K)

III. PENUTUP

Demikian Rincian Kegiatan Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Untuk Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan ini disusun untuk dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

melalui penerimaan DBH CHT Bidang Kesehatan, sehingga terlaksana secara tepat guna, tepat sasaran dan memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.

Dukungan partisipasi aktif dari para pihak sangat diperlukan, baik para pemangku kebijakan, peran lintas sektor, peran lintas program, dari berbagai elemen masyarakat dan media, guna terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.

Sekretaris Jenderal,



Kunta Wibawa Dasa Nugraha